

Nadwartościowanie *wagi i kształtu* — rdzeń

CBT-E (Fairburn) — najlepiej zewalutowana terapia dorosłych z AN. Transdiagnostyczna: ten sam mechanizm rdzenny wyjaśnia AN, bulimię, BED, OSFED.

CZAS: 20 min psychoedukacji modelu **REALIZACJA:** każdy pacjent — pierwsza psychoedukacja CBT-E

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008, *Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders*); Fairburn, Cooper & Shafran (2003, *transdiagnostic theory*); NICE (2017, NG69 — CBT-ED rekomendacja A)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **rdzeń modelu**: nadwartościowanie (ang. *over-evaluation*) wagi, kształtu i kontroli nad nimi jako mechanizm podtrzymujący wszystkie zaburzenia odżywiania. W sekcji 02 — **cztery dodatkowe mechanizmy** wersji „broad”: perfekcjonizm kliniczny, niska samoocena rdzeniowa, trudności interpersonalne, niska tolerancja afektu. Sekcja 03 — **twoja konceptualizacja**: na ile mój obraz siebie zależy od wagi/kształtu? Co innego mnie definiuje? Sekcja 04 — implikacje terapeutyczne.

DLACZEGO TO DZIAŁA

CBT-E (Fairburn, 2008, *Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders*) — najlepiej zewalutowana terapia dla zaburzeń odżywiania. **Model transdiagnostyczny**: wszystkie ED (AN, BN, BED, OSFED) podtrzymuje ten sam mechanizm — **nadwartościowanie kontroli nad jedzeniem, kształtem ciała i masą**. Z tego wynikają wszystkie objawy: restrykcja, napady, kompensacja, body checking, food rules. Terapia trwa 20–40 sesji w 4 fazach — od regularnego jedzenia (faza 1) do utrwalania zmiany (faza 4).

01 Rdzeń modelu — nadwartościowanie wagi i kształtu

Centralny mechanizm AN i wszystkich zaburzeń odżywiania: ocenianie siebie *głównie* lub *wyłącznie* przez pryzmat wagi, kształtu ciała i kontroli nad jedzeniem. Z tego rdzenia wynikają *wszystkie* pozostałe objawy.

Błędny krąg podtrzymujący: nadwartościowanie → sztywne reguły żywieniowe → restrykcja → niedożywienie → „głodny mózg” (obsesje pokarmowe, sztywność poznawcza, zaburzenia nastroju) → *jeszcze większa* koncentracja na wadze → nadwartościowanie się *utrwała*. To samonapędzający się cykl, który *nie* zatrzyma się sam.

Pytanie diagnostyczne dla modelu: „Na ile twój obraz siebie zależy od wagi i kształtu ciała?”. Pacjent z AN: zwykle 80–100%. Osoba bez zaburzenia: 20–30%.

02 Cztery dodatkowe mechanizmy (wersja „broad”, Fairburn 2003)

1 • PERFEKCJONIZM KLINICZNY

Nadwartościowanie osiągnięć w wąsko zdefiniowanym obszarze. Kontrola wagi staje się „obszarem doskonałości”, w którym można osiągnąć perfekcję, niemożliwą w innych dziedzinach.

2 • NISKA SAMOOCENA RDZENIOWA

Globalnie negatywny obraz siebie — niezmienny mimo osiągnięć. „Cokolwiek zrobię, nie wystarczy”. Kontrola wagi jako jedyny sposób zyskania (chwilowego) poczucia wartości.

3 • TRUDNOŚCI INTERPERSONALNE

Relacje jako źródło stresu. „Jedzenie i ciało” stają się obszarem kontroli, gdy inne obszary życia (relacje, role) są chaotyczne, niekontrolowalne lub bolesne.

4 • NISKA TOLERANCJA AFEKTU

Trudność z tolerowaniem trudnych emocji. Głodzenie lub epizody objadania jako somatyczny sposób na regulację — emocje są „za dużo”, więc ciało tłumii je przez zmianę spożycia.

03 Moja konceptualizacja (do pracy z terapeutą)

NA ILE MÓJ OBRAZ SIEBIE ZALEŻY OD WAGI I KSZTAŁTU

— skala 0–100%; co jeszcze mnie definiuje (relacje, pasje, wartości, charakter)

KTÓRE DODATKOWE MECHANIZMY ROZPOZNAJĘ U SIEBIE

— perfekcjonizm / niska samoocena / trudności interpersonalne / niska tolerancja afektu; może być kilka

MOJE SZTYWNE REGUŁY ŻYWIENIOWE

— co wolno, czego nie wolno, w jakich ilościach, w jakich godzinach; bez konkretnych liczb — tylko struktura

CO MOGŁOBY ROZSZERZYĆ MÓJ „PASEK SAMOOCENY”

— co innego niż waga/kształt mogłoby zyskać znaczenie; jakie obszary chciałbym/-łabym rozwijać

Klucz: CBT-E nie pracuje wyłącznie z zachowaniami jedzeniowymi — pracuje z *rdzeniem poznawczym*: nadwartościowaniem wagi i kształtu jako głównym wymiarem samooceny. Bez pracy z rdzeniem zachowania powracają, nawet po krótkotrwałej poprawie wagi. CBT-E jest *strukturalna*: 20–40 sesji w czterech etapach (start, ewaluacja postępu, rdzeń, zakończenie), z konkretną sekwencją modułów. Psychoedukacja modelu jest *pierwszym* krokiem — pacjent rozumie, *dlaczego* pracuje nad konkretnymi obszarami. Wersja „broad” (z dodatkowymi 4 mechanizmami) dla pacjentów z silnym perfekcjonizmem, niską samooceną, trudnościami interpersonalnymi lub niską tolerancją afektu — dla pozostałych standardowa wersja „focused”. NICE (2017, NG69) rekomenduje CBT-ED jako leczenie pierwszego rzutu dorosłych z zaburzeniami odżywiania.

△ CBT-E dla AN ma specyficzne wyzwania: u pacjentów z bardzo niskim BMI praca poznawcza ma ograniczoną skuteczność („głodny mózg” — osobny handout), więc równoległą praca z odżywieniem jest warunkiem koniecznym. CBT-E dla AN wymaga doświadczenia klinicysty — terapia z bardziej skomplikowaną sekwencją niż w bulimii.